

## 17 - 05- Acné - Pr. Amal

Bonjour, donc le cours d'aujourd'hui est intitulé l'acné. Les objectifs de ce cours, c'est donc après ce cours, l'étudiant doit être capable de diagnostiquer l'acné, donc l'acné il est de diagnostic clinique, facile, reconnaître les formes graves de l'acné, donc les acnés sévères, l'acné mondialologique et l'acné fulminance, expliquer les mécanismes physiopathologiques de l'acné, traiter les formes non graves, citer les principes du traitement des formes graves. L'acné est une pathologie fréquente, c'est une maladie fréquente de follicules pylosébacées, ce que vous voyez ici, donc vous avez la glande sébacée, vous avez le canal sébacé, donc là c'est une pathologie des follicules pylosébacées.

Il touche, l'acné touche 80% des adolescents, mais uniquement 10% de ces adolescents nécessitent un avis, une prise en charge médicale. Les formes graves représentent 1%, les formes graves, on parle des formes graves, surtout donc l'acné mondialologique, on appelle donc l'acné conglobata et l'acné fulminance. Donc le pic de fréquence chez les filles, il est de 14 à 16 ans, et chez les garçons c'est entre 16 et 17 ans.

Il faut savoir que l'acné peut persister chez les femmes après un certain âge, donc après 25 ans jusqu'à 40 ans, et ça touche 20% des femmes. L'acné est une maladie, en général c'est une maladie bénigne, mais il faut faire attention. L'acné peut retentir sur la qualité de vie.

Donc il y avait des cas de suicide chez les adolescents acnéiques, donc il faut faire attention, il ne faut pas sous-estimer cette maladie, donc il faut écouter vos patients et il faut les traiter. Sur le plan physiopathologique, il y a trois éléments qui sont importants. Il y a la séborée, l'hyper séborée, donc là c'est la glande sébacée qui sécrète le sébum, on parle d'hyper séborée, et puis vous avez le trouble de la kératinisation infundibulaire, et ce canal sébacé sera bouché, il y aura fermeture, et après il y aura stagnation du sébum et du kératinocyte, et une inflammation folliculaire secondaire, où il y a l'intervention de la flore bactérienne, surtout du proprio bactérium acnéis.

L'élément le plus important, c'est l'hyper sécrétion sébacée, donc faite par la glande sébacée, stimulée par la dihydrotestostérone, dihydrotestosterone, c'est un dérivé de la testostérone, donc sous l'enzyme 5-alpha-réductase, qui va transformer la testostérone en dihydrotestosterone, et il y aura une stimulation de l'hyper sécrétion sébacée. L'origine de la testostérone, vous avez la dihydro-épiandrosterone, et la testostérone sécrétée par les testicules chez le sujet masculin et les ovaires chez la femme, les urinales sécrètent la dihydro-épiandrosterone. Pour récapituler, voici les étapes de la physiopathologie de l'acné.

Donc première étape, l'hyper séborée. L'hyper séborée, c'est à cause de cette glande sébacée qui va sécréter le sébum de façon importante, donc de façon importante, et cette sécrétion, elle est due à l'augmentation du nombre et de la sensibilité des récepteurs au dihydrotestostérone, mais également au niveau de la glande sébacée, il y a d'autres récepteurs, surtout les récepteurs

au neuromédiateur, surtout la substance P, donc ce qui explique qu'en général, les adolescents font beaucoup de poussées d'acné pendant les périodes de stress, par exemple pendant les périodes d'examen. C'est à cause de ces récepteurs au neuromédiateur.

Donc la deuxième étape, c'est l'obstruction de l'infundibulum, du canal infundibulaire. Donc cette obstruction est due à un trouble de la kératinisation, à une production excessive des kératinocytes, et il y aura une obstruction avec formation des micro-kistes qu'on appelle les micro-comédons. Donc cette obstruction est secondaire à des modifications qui atteignent les kératinocytes, vous avez des modifications des intégrines, il y aura une production importante d'un interleukin 1 $\alpha$  par les kératinocytes, ce qui va augmenter le chimiotaxisme du polynucléaire.

Il y a également une diminution de la concentration de l'acide lénolique. Donc tout ceci aboutit à l'obstruction et à la formation des micro-comédons. La troisième étape, c'est l'étape inflammatoire.

Cette inflammation est secondaire à la flore bactérienne qui existe au niveau du follicule pylocépaceae, donc sur tout le proprio bactérium acnes. Il y a également des enzymes qui entretiennent cette inflammation, vous avez la lipase, les métalloprothéases, et vous avez donc des cytokines qui vont aggraver cette réaction inflammatoire. Donc vous avez, pour récapituler, la stimulation androgénique qui va donner une sécrétion de la glande sébée de sébum, une hyper-séborée, associée à une kératinisation infundibulaire, et puis vous avez l'étape de l'inflammation où il y a l'intervention des coriognes bactéries anaérobies, sur tout le proprio bactérium acnes, et actuellement on a identifié d'autres coriognes bactéries.

Il y a l'intervention des enzymes, la lipase, les métalloprothéases, l'activation des compléments, il y a donc une activation du chimiotaxisme du neutrophile, tout ceci va donner donc une inflammation. Donc à partir de la physiopathologie, on va comprendre les présentations cliniques des patients. Donc le patient, qu'est-ce qu'il aura comme lésion élémentaire? Il y aura une hyper-séborée.

Une hyper-séborée, ça va se traduire par un aspect luisant du visage, un aspect huileux au niveau du front, au niveau du nez, au niveau des joues. Et vous avez donc l'hyper-séborée, vous avez, on a dit, la formation des microcomédons. Donc qu'est-ce que ça va donner cette formation des microcomédons? Ça va donner ces lésions que vous voyez là, ce qu'on appelle des microkistes.

Donc ce sont des papules de petite taille, de moins de 5 mm de diamètre, blanc ou noir, ce qu'on appelle communément les points noirs. Donc la différence entre les microkistes blancs et les microkistes noirs, ici c'est des microkistes fermés, et là c'est ouvert, et là donc c'est l'oxydation du sébum qui est dans cet aspect noirâtre. Donc microkistes ouverts, microkistes fermés, ou comédons blancs, comédons noirs.

Donc ces lésions siègent au niveau, essentiellement au niveau du front, au niveau des joues et

au niveau du nez. Donc là, ces lésions représentent l'acné rétentionnel, l'acné rétentionnel. Après ces lésions, il y a donc un risque d'évolution vers l'inflammation, donc la troisième étape de la physiopathologie.

Et à ce moment-là, on aura, à côté de ces éléments rétentionnels, des microchistes ouverts et microchistes fermés, des éléments noirs. Donc vous avez ici des images de microchistes. Donc vous voyez les microchistes, avec quelques éléments inflammatoires, les pustules qu'on va voir par la suite.

Les microchistes que vous voyez ici, les microchistes, donc les microchistes, les points noirs. Voici les microchistes ici, les points blancs, les microchistes donc ici fermés. Et les points noirs ici que vous voyez, donc les microchistes ouverts, les comédons.

Les lésions peuvent siéger également au niveau du dos. Donc vous voyez les comédons ouverts, donc les points noirs. Et voilà, donc les lésions évoluent vers l'inflammation.

Donc ce n'est pas obligatoire. Il peut, certains malades présentent une acné rétentionnelle pure, sans éléments inflammatoires. Mais en général, l'évolution de ces éléments rétentionnels, si on ne les traite pas, il y a donc l'évolution vers l'acné inflammatoire.

Et on aura des papules inflammatoires, des pustules. Donc les pustules, c'est des lésions à compte tenu, de petite taille à compte tenu, périllant. Les papules, c'est des lésions de moins de 5 mm de diamètre, donc inflammatoires, rouges.

Et chez les malades, on peut avoir les deux, les papules et les pustules. Donc on va voir les différentes formes cliniques. Donc on va commencer par la forme la plus fréquente, l'acné pubertaire chez les adolescents.

Donc vous avez l'hyperseborée, puis vous avez les microcystes, ouverts et fermés, localisés au niveau du front joues et nez. Et puis vous avez l'évolution de ces lésions vers les éléments inflammatoires. Vous voyez ici les pustules, les pustules que vous voyez ici.

Donc c'est une acné mixte, avec des lésions rétentionnelles et des lésions inflammatoires. La même chose ici. Ici c'est une pustule.

Ici vous voyez les microcystes, les comédons, ce que vous voyez ici, les comédons. Et là les papules et les pustules. Donc lorsqu'il y a l'association des comédons ouverts, des microcystes, des papules et des pustules, on parle d'acné polymorphe ou d'acné juvénile.

Donc c'est des noms que vous allez trouver dans la littérature. Selon la prédominance des types de lésions, on parle d'acné à prédominance rétentionnelle ou inflammatoire. Donc ici vous voyez qu'il y a plusieurs microcystes.

Et également vous avez ici des pustules et des papules. Donc c'est une acné inflammatoire. Donc

ici, acné à prédominance rétentionnelle.

Là par contre on voit plus de pustules et de papules inflammatoires. Donc c'est une acné à prédominance inflammatoire. La même chose ici, vous voyez les pustules sur un fond inflammatoire, des papules, des pustules et les lésions au niveau du cou, des pustules.

Donc c'est une acné inflammatoire, prédominance inflammatoire. Donc on va voir maintenant les formes sévères. Vous avez l'acné conglobata.

Donc l'acné conglobata, on est devant des nodules multiples de prise de 5 mm de diamètre. Donc c'est des lésions en général de grande taille, parfois confluentes, douloureuses, parfois suppuratives. Donc ces lésions siègent essentiellement au niveau du visage.

Parfois donc ils défigurent le visage avec un retentissement important sur la qualité de vie. Mais le plus souvent chez les malades qui ont ces formes d'acné conglobata, on trouve des lésions au niveau du tronc, au niveau des épaules, au niveau des racines des membres, surtout les racines des membres supérieurs. Ces lésions évoluent vers des cicatrices, soit atrophiques, soit le plus souvent des cicatrices hypertrophiques avec des brides.

Aussi donc des lésions au niveau du visage chez ce patient. Et là on voit déjà des lésions cicatricielles, des anciennes lésions nodulaires. Et vous voyez les lésions nodulaires avec ici donc une des brides.

Les lésions nodulaires également chez cette femme. Voici la lésion au niveau du tronc. Également on voit qu'il y a des cicatrices atrophiques, déprimées, mais également il y a des lésions nodulaires évolutives.

Donc on est devant une acné conglobata. Donc l'acné fulminant c'est la forme la plus grave de l'acné. Donc vous avez des lésions en général nodulo-kystiques comme l'acné conglobata, mais des lésions qui évoluent vers des ulcérations et des lésions donc et des nécroses, des lésions nécrotiques, noirâtres, ce que vous voyez ici.

C'est des lésions ulcéronécrotiques. Donc la différence entre l'acné fulminant c'est l'acné donc nodulo-kystique, c'est cette évolution ulcéronécrotique des lésions, mais également l'existence de signes généraux. Donc c'est des patients qui arrivent aux urgences avec altération de l'état général, une fièvre élevée, donc 39-40, des douleurs articulaires et des douleurs musculaires.

C'est des patients qu'on hospitalise, qu'on traite en milieu hospitalier. L'acné néonatal est infantile. Donc l'acné néonatal c'est une acné qui est transitoire, se voit plus chez les garçons.

Il est dû à la stimulation des glandes sébassées par les hormones homogéniques maternelles. Il est transitoire, tant qu'il n'y a plus de ces hormones, les lésions regressent. Donc chez un nouveau-né, si vous avez des lésions d'acné, c'est pas inquiétant.

Par contre, chez l'enfant, après deux ans, là, si vous avez des lésions d'acné, chez des enfants, il faut mener une enquête étiologique parce que c'est pas normal qu'un enfant présente des lésions d'acné. Il faut rechercher une hyperplasie congénitale du surrénal ou une tumeur ovarienne au surrénalien. Donc il faut faire des explorations hormonales et radiologiques.

Les lésions d'acné chez un enfant, là, vous voyez les lésions d'acné, donc avec des nodules ici, des papules. Donc c'est pas normal qu'un enfant présente ces lésions. Là, il faut faire une exploration biologique et radiologique.

On a dit que l'acné peut persister chez les femmes, donc après 25 ans. Et là, il faut chercher une cause. Il faut tout d'abord, cliniquement, chercher s'il y a des signes d'hyperandrogénie.

Chez cette patiente, par exemple, les signes d'hyperandrogénie, il faut chercher un leucitisme. Il faut également l'alopecie androgénogénétique. Il faut chercher si la patiente prend des médicaments, prend un traitement hormonal, par exemple.

Chez certains patients, l'explication de la persistance des lésions d'acné peut être due à l'utilisation des cosmétiques mal adaptés. Il faut utiliser des cosmétiques non-chromatogènes. Chez ces patients, il faut faire un bilan hormonal.

Donc le bilan hormonal, il faut le faire le matin, entre troisième et sixième jour de cycle. On demande dosage du testostérone libre, delta-4-androsténédione, sulfate d'hydroépiandrostérone, 17 OH progestérone. Les patientes doivent arrêter la contraception au moins deux mois avant de faire ce bilan.

Et l'étiologie la plus fréquente, c'est surtout le syndrome des ovaires polymicrocystiques. Là également, donc il faut faire une exploration radiologique, une échographie pelvienne, donc qui va vous montrer ces cystes au niveau des ovaires. Il y a d'autres étiologies qui sont plus rares.

Vous avez difficile 17 $\alpha$ -hydroxylase, des tumeurs de l'ovaire et de la surrénale, syndrome de Cushing, l'hyper-androgénisme hiatrogène, secondaire à certaines prises médicamenteuses par exemple. Donc l'acné inversa ou la maladie des verneux, c'est pas une vraie acné puisque c'est une pathologie qui touche les glandes apocrines et non pas les glandes sébacées. Donc cliniquement, vous avez des lésions modulaires, séparatifs.

Vous avez aussi des lésions au niveau du creux axillaire, ça peut toucher les autres plis, notamment le pli inguinal et la région périneau-fessière. Le pli se voit associé à des lésions d'acné conglobata. Parfois, on trouve également des lésions de folliculite séparatif cicatriciel atrophique au niveau du creux chevelu.

Ça touche plus le sujet de sexe masculin que le sujet de sexe féminin. Et là, vous avez des lésions donc périneau-fessière, des lésions séparatifs, pérulantes. Donc là, si vous voyez cette patiente qui était sous corticothérapie au long cours, elle a développé ces lésions.

Vous avez des pustules et vous avez des papules. Mais vous n'avez pas d'éléments rétentionnels. Il n'y a pas de microcystes blancs ou des microcystes noirs.

Pas de comédons ouverts ou fermés. En même chose, cette patiente qui est sous corticothérapie, vous voyez, c'est des pustules et des papules diffusent au niveau du visage. En même chose, c'est ce patient au niveau du tronc et également, c'est ce patient qui a des pustules diffusées au niveau du dos.

Donc, tous ces patients présentent des lésions dites acnéiformes. Il n'y a que les éléments inflammatoires. Il n'y a pas de microcystes.

Donc, ce n'est pas une acné. Ce sont des lésions acnéiformes secondaires à des prises médicamenteuses. Donc, certains médicaments ont des lésions qui ressemblent à l'acné.

Actuellement, on les appelle plus des toxidermies acnéiformes. Donc, vous avez la liste de ces médicaments. Donc, surtout les corticoïdes, les cas des deux patients qu'on a vus.

Vous avez la vitamine B12. Sur les malades qui ont un déficit de la vitamine B12. Vous avez les antibacillaires et vous avez la cyclosporine.

Ce sont ces médicaments qui donnent des lésions acnéiformes. Vous avez la liste des autres médicaments, les antidépresseurs et les autres médicaments que vous voyez dans ce tableau. Là, donc toujours dans le cadre du diagnostic différentiel puisqu'on a vu un petit peu l'acné inversé.

On a dit que ce n'est pas une acné. C'est une pathologie de grande apocrine. On a vu les toxidermies médicamenteuses acnéiformes.

Là, également, vous avez, c'est un diagnostic différentiel. Vous avez ici des pustules et c'est une patiente âgée avec un irritème facial et des dilatations vasculaires, ce qu'on appelle les télangiectasies. Donc, ça, c'est la rosacée.

Donc, la rosacée, ça associe un irritème, des télangiectasies et parfois on a des papules et des pustules. Là, ce que vous voyez, c'est des papules. On diffuse au niveau du signon nasogénien, au niveau du menton.

Ils ont une consistance un peu molle. Ce sont des ongiophibromes. C'est un diagnostic différentiel.

On voit ces lésions dans une maladie génétique qui s'appelle la sclérose tubéreuse de Bourneville qui associe une atteinte cutanée, une atteinte neurologique. Donc, en général, c'est des malades qui ont des épilepsies avec donc des lésions cutanées. Là, vous voyez des pustules de cette taille.

En général, certaines parasitoses qu'on appelle les démocidoses peuvent donner ces lésions, donc un aspect un petit peu inflammatoire avec des pustules. C'est également une dermatite ciborique avec des pustules qui peuvent être également secondaires à la pitulospore ovale. Ce sont les principaux diagnostics différentiels des lésions d'acné.

Donc, pour la prise en charge de l'acné, on va voir les moyens thérapeutiques. Donc, il y a des moyens locaux. Vous avez les rétinoïdes topiques.

Les rétinoïdes, c'est les dérivés de la vitamine A. Vous avez l'acide rétinoïque, tous trans ou trétinoïdes. L'acide 13-6-rétinoïque, donc ce sont des dérivés ou isotrétinoïdes, des dérivés de la vitamine A. Nadapalène également, donc tous ces médicaments, ce sont des dérivés de la vitamine A. Ils sont dosés, donc des dosages variables. Donc, pour l'acide rétinoïque, vous avez le 0,025, 0,05%.

Donc, l'Adapalène, il n'y a qu'un seul dosage. Ce sont des médicaments qui ont une activité chérolithique. Donc, ils vont agir sur les comédons.

Leur indication est l'acné rétentionnelle. Sauf pour l'Adapalène qui, à côté de cette activité chérolithique, il a une activité également anti-inflammatoire. L'effet secondaire majeur est l'irritation.

Donc, toujours dans les moyens thérapeutiques locaux, vous avez le peroxyde de benzoyl utilisé aux doses de 2,5, 5 et 10%. 10% c'est pour les lésions du dos. Il est légèrement comédolithique, mais puissamment antibactérien.

Il n'y a pas de résistance bactérienne connue, contrairement aux antibiotiques locaux. Les effets secondaires majeurs, l'irritation et la photosensibilisation. Ce sont des médicaments qu'on arrête pendant l'été.

Il y a un autre effet secondaire qu'il faut connaître. Ce sont des médicaments, ce peroxyde de benzoyl, il décolore les vêtements. Ça c'est très important, il faut avertir le patient.

Et puis, toujours dans les moyens thérapeutiques locaux, vous avez les antibiotiques locaux. Vous avez l'Erythromycine et la Clindamycine. Ils agissent sur la flore bactérienne et comme anti-inflammatoires non spécifiques.

Ils agissent sur la flore bactérienne, donc surtout contre le *Propionibacterium acnes*. Ils agissent comme anti-inflammatoires non spécifiques, surtout contre la lipase. Leur activité est modeste si on la compare au peroxyde de benzoyl et il est partiellement remis en cause du fait de l'émergence des résistances bactériennes.

Dans certains pays, ils ont interdit la commercialisation des antibiotiques locaux en cause de l'émergence des résistances bactériennes. Toujours dans les thérapeutiques locales, dans le

traitement local, on peut utiliser l'association, donc il y a une crème qui associe les deux principes actifs, peroxyde de benzoyl et Adapalene. Donc ce produit, il est comédolithique parce qu'il contient de l'Adapalene et puissamment antibactérien parce qu'il contient du peroxyde de benzoyl et il n'y a pas de résistance bactérienne.

C'est un produit qui a été comparé à l'utilisation en alternatif de peroxyde de benzoyl un soir sur deux et l'Adapalene un soir sur deux est plus puissant que le peroxyde de benzoyl seul, que l'Adapalene seul est plus puissant que l'utilisation des deux. Les effets secondaires, ça regroupe les effets secondaires de l'Adapalene de peroxyde de benzoyl, l'irritation, la photosensibilisation et également il peut décolorer les vêtements parce qu'il contient du peroxyde de benzoyl. Maintenant on va passer aux moyens thérapeutiques généraux.

Vous avez les antibiotiques, donc surtout les cyclines, différents types de cyclines, les tétracyclines, la doxycycline, l'imicycline et minocycline. Faut faire attention, la minocycline en général, il faut la laisser en dernière intention parce qu'il peut donner des effets secondaires sévères, notamment des toxidermies sévères, donc le Drey syndrome, surtout chez les sujets de race noire. Et vous avez les macrolides qu'on utilise lorsqu'il y a une contreindication cycline, donc les macrolides, l'irritromicine, la roxitromicine, la josamicine, on les utilise quand les cyclines ne peuvent pas être prescrites, par exemple en cas de grossesse.

Les antibiotiques, ils ont une activité antibactérienne, elles agissent sur les proprios bactériums acnes et anti-inflammatoires non spécifiques, elles agissent également sur la lipase. Le glycournat de zinc, donc il n'est pas commercialisé au Maroc, il est également doté d'une activité anti-inflammatoire, mais inférieure à celle des cyclines. Il est utilisé en cas de contreindication des cyclines et surtout pendant l'été, puisque les cyclines sont des médicaments qui sont photosensibilisants.

Dans le traitement général, vous avez l'ésotrétinoïne, donc c'est un inhibiteur non-hormonal de la sécrétion sévacée, il inhibe complètement la sécrétion sévacée. C'est un traitement anti-rétentionnel et modérément anti-inflammatoire. Ses effets secondaires doivent être parfaitement connus, donc le risque thératogène, c'est très important, il faut informer les patients.

La contraception doit être obligatoire avant de démarrer le traitement, pendant le traitement et un mois après le traitement. Il donne une sécheresse cutanéomiqueuse, dose dépendante, puisque ça inhibe la sécrétion sévacée. La kéylite, elle est obligatoire.

Et vous avez la xéroscutanée, donc il faut hydrater la peau, il faut utiliser des baumes pour les lèvres. Ça peut donner une conjonctivite. Les pores de l'ontie sont contraindiqués.

Et également, il peut donner une rhinite sèche responsable d'hépiptaxis. Il peut y avoir une exacerbation de l'acné pendant les 4 premières semaines de traitement. Il y a un risque d'hypertension intracrânienne en association avec les cyclines.



Il faut respecter un délai de 15 jours. Si le malade était sous-cycline et vous voulez passer à l'isotrétinoïde par voie orale, il faut un délai de 15 jours. Donc il y a le risque d'élévation des transaminases et l'hyperlipidémie.

Donc il faut faire des dosages avant le traitement et pendant le traitement, donc avec un schéma qu'on va voir par la suite. Et puis vous avez l'hormonothérapie. L'hormonothérapie, bien sûr, elle est réservée au sexe féminin et associe un oestrogène éthinyl oestradiol à un anti-androgène, l'acétate de ciprothérone.

Son efficacité est limitée et lente. En général, ça nécessite entre 6 mois et 9 mois de traitement pour avoir des résultats. Quel que soit le traitement, il faut donner des conseils à vos patients.

Il ne faut pas presser les comédons. Sinon, il y a un risque important de cicatrices. L'acné peut être guéri, mais les cicatrices peuvent persister toute la vie.

Le nettoyage de peau ne peut être qu'un complément éventuel au traitement. Il est inutile, voire préjudiciable, de passer un antiseptique sur les lésions ou de faire une toilette énergique. L'acné, ce n'est pas une maladie infectieuse.

Donc, ça ne sert à rien d'utiliser les antiseptiques. Vous risquez d'irriter le visage et de créer des lésions inflammatoires qui peuvent pigmenter. Certains cosmétiques pérennisent l'infection.

Donc, surtout l'utilisation des fonds de teint par, en général, les adolescents pour cacher les lésions, ça peut donc aggraver les lésions d'acné. Ces cosmétiques ne doivent pas être interdits chez la femme, mais doivent être adaptés au sujet des cosmétiques non-comédogènes, testés non-comédogènes. Le soleil réduit considérablement le caractère inflammatoire des lésions, mais il facilite la comédogénese.

En général, on a une amélioration pendant l'été, mais suivie d'une poussée d'acné en automne. C'est pour cela qu'on appelle le soleil le faux ami de l'acnéique, parce qu'il donne une amélioration au départ, puis il y a une aggravation. En général, il n'y a pas de régime alimentaire à suivre, mais en général, on conseille aux patients, donc, d'avoir une alimentation équilibrée avec des fruits et des légumes et d'éviter, donc, les produits en général, la matière grasse.

Les effets de traitement ne sont jamais rapides. Il faut donc expliquer ça aux patients pour qu'ils adhèrent au traitement. En général, il faut donc, en fonction du tableau clinique, du schéma thérapeutique, il faut au moins se patienter pendant trois mois pour évaluer les résultats du traitement.

Donc, pour les indications thérapeutiques, devant une acnée rétentionnelle, on utilise l'iricinoïtopique. Une seule application le soir. C'est un produit irritant, il faut éviter d'appliquer sur les paupières, sur le poteau de la bouche.

Si vous êtes devant une acnée modérément inflammatoire, donc, on peut utiliser la dapalène seule, parce que la dapalène, elle a une activité en caratolytique et également une activité inflammatoire, anti-inflammatoire, ou bien l'iricinoïtopique associé au peroxyde de benzoïde. On a dit qu'il y a une crème qui associe les deux. Ou bien, on utilise un soir l'iricinoïtopique, un soir le peroxyde de benzoïde.

Et parfois, on peut utiliser une antibiotérapie locale associée au iricinoïde, surtout, par exemple, pendant l'été, où le peroxyde de benzoïde, en général, c'est un produit photosensibilisant qu'on arrête son utilisation pendant l'été. Pour les acnées, donc, pas pyropistuleuses, les acnées inflammatoires, donc, on utilise une antibiotérapie générale. En général, la durée de traitement, elle est de trois mois.

On choisit une cycline de pleine, donc, les nouvelles cyclines. Vous avez une limicycline en raison de 300 mg par jour, la doxycycline 100 mg par jour, et il faut laisser la minocycline en seconde intention. Les tetracyclines dans les cyclines de base, ils ont également des effets digestifs, donc, on préfère les cyclines de nouvelle génération, la limicycline et la doxycycline.

En cas de contreindication des cyclines, on utilise l'iricomycine un gramme par jour ou le glyconate de zinc. Le glyconate de zinc, il n'est pas commercialisé au Maroc. Associé au ritinoïtopique, peroxyde de benzoïde.

Pour l'acné nodulaire au conglomata, on utilise l'isotrétinoïne. Sa posologie optimale est comprise entre 0,5 et 1 mg par kilo par jour, et le traitement doit être poursuivi jusqu'à une dose cumulée optimale, en général, entre 100 et 150 mg par kilo par cure. En général, on prend une moyenne de 120 mg par kilo par cure.

Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un patient, donc, il n'y a pas de durée de traitement, donc, on va prescrire, en général, on commence par 0,5 mg par kilo par jour. On peut augmenter jusqu'à 1 mg en fonction de la tolérance kilo par jour. Et pour la durée de traitement, il faut calculer la dose cumulée.

Donc, il faut calculer, par exemple, s'il prend 0,5 mg, s'il prend, par exemple, 20 mg par jour, donc, il faut calculer 20 mg par jour pendant un mois, ça veut dire qu'il a pris pendant un mois 20 qui multiplie 30. Et ainsi de suite, on va calculer toute la dose, donc, qu'il a pris pendant la cure. Et s'il arrive à la dose de 120 mg par kilo, on arrête le traitement.

On peut aller jusqu'à 150 mg par kilo par cure. Ce médicament est teratogène, donc, une information détaillée doit être fournie et un consentement doit être signé par la patiente ou le représentant légal dans le cas d'une patiente mineure. Ce traitement nécessite un dosage initial de transaminase, du cholestérol et du triglycéride, et puis une surveillance périodique de ce bilan, en général, tous les trois mois.

Pour l'acné filminance, le traitement repose sur la corticothérapie générale à raison de 0,5 mg par

kilo. On arrête de façon progressive et qu'on introduit les œufs rétinoïdes, donc, de façon également progressive. Les complications de l'acné, vous avez surtout les cicatrices.

Vous voyez les cicatrices déprimées ici au niveau du dos. Il y a d'autres complications qui sont rares, donc, l'infarction persistant chez des patients qui présentent des formes sévères d'acné. Le rhumatisme acnéique, donc, c'est des lésions inflammatoires avec des douleurs importantes au niveau des points d'insertion épiphysaire des tendons ou le rhumatisme acnéique dans le cadre du syndrome SAFO, donc, c'est un syndrome qui associe une synovite acné-pistulose-hyperostose- hypo-ostéite.

Et également, comme complication rare, vous avez l'amylose. Donc, l'amylose, c'est une complication de supériorité chronique, donc, des lésions, des malades qui présentent des acnés non-dilatoires de façon chronique peuvent développer une amylose, donc, qui peut se compliquer d'une insuffisance rénale. Voici, donc, les cicatrices.

Ici, les cicatrices atrophiques au niveau du visage. Ici, des cicatrices qu'iloudiennes au niveau du tronc. Et parmi les complications, vous avez ces pustules que vous voyez ici, des pustules dues en général au bacillus gamma négatif.

C'est des pustules secondaires à l'utilisation des cyclines de façon prolongée, plus de trois mois, ou des cyclines associées à une antibiothérapie locale. Donc, c'est l'émergence des résistances bactériennes. Donc, l'acné est une pathologie fréquente.

C'est une pathologie de l'adolescent essentiellement. C'est une maladie qui altère la qualité de vie, soit dans les formes sévères acné non-dilatoires ou même parfois dans les formes minimales. Il faut adapter le traitement en fonction du tableau clinique.

Il n'y a pas d'ordonnance type pour tous les types d'acné. Donc, il faut voir le malade, l'examiner, voir quelle est la forme clinique présente et adapter le traitement en fonction du tableau clinique. L'isotrétinoïne est une arme efficace qu'il faut savoir manipuler.

Donc, il nécessite une surveillance particulière, clinique et biologique.